



EDITORIAL

Evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOE)

Objective and structured clinical assessment (ECOE)



Una ECOE consta de una serie de casos estructurados a los que el alumno se enfrenta de forma secuencial y que están configurados sobre la base de la simulación. Sin embargo, los resultados que se obtienen son muy reales, acerca del nivel de adquisición de competencias clínicas por parte de los estudiantes. En cada una de las estaciones, el alumno debe realizar tareas específicas, relacionadas habitualmente con la anamnesis de un paciente estandarizado, la exploración clínica, ciertas habilidades clínicas o procedimientos, interpretación de resultados y manejo de los problemas, comunicación, relaciones interpersonales, ... Cada estación busca evaluar en porcentajes variables distintas áreas competenciales a partir de un encuentro del estudiante con pacientes estandarizados, maniqués, resultados de pruebas, preguntas estructuradas realizadas por un observador, ordenadores, llamadas telefónicas,...

Todo ello se planifica con antelación, así como el tiempo asignado a cada estación, el número de estaciones (que dependerá de si diseñamos una ECOE parcial, por ejemplo de una materia o asignatura, o una ECOE global, por ejemplo al término de los estudios de grado). La clave de la fiabilidad de la ECOE es el número de estaciones: cuanto mayor sea la cantidad de estaciones objeto de calificación por los distintos evaluadores más fiable será la ECOE. Sin embargo, debe encontrarse un equilibrio con los aspectos prácticos, y la materia cuyo aprendizaje ha de evaluarse.

Por tanto, se trata de una prueba evaluativa en la que "tenemos controlado" el área o áreas competenciales que vamos a evaluar, cómo lo vamos a hacer, a través de qué instrumentos, qué es lo que vamos a puntuar, cual es la dimensión de cada ítem que vamos a valorar, etc. Una prueba evaluativa, en fin, que se encuentre controlada en su diseño y ejecución, procesos en los que habrán de participar numerosas personas. Por tanto una de sus principales ventajas es que permite evaluar a un gran número de candidatos del mismo modo y en una diversidad de habilidades clínicas. De hecho, el elevado grado de fiabilidad y validez de una ECOE, que justifica que sea una evaluación de alto impacto tanto en pregrado como en

postgrado, viene determinado por una serie de características propias¹:

- El plan de calificación se encuentra estructurado, lo que permite una puntuación consistente por parte de los evaluadores.
- Disponemos de distintas observaciones independientes reunidas en las distintas estaciones, con lo que se aminora el sesgo que puede ofrecer un evaluador individual.
- Es una muestra extensa de diferentes casos, habilidades, procedimientos, informes, etc., lo que proporciona una imagen más fiable de la competencia global.
- El desempeño se muestra en un gran número de estaciones, lo que hace posible que la evaluación sea más generalizable.
- A ello deberíamos sumar que, si deseamos que la prueba ofrezca resultados comparables entre los candidatos a efectos de acreditar su nivel competencial, la prueba habrá de ser igual para todos.

Como sucede con todos los elementos de cualquier evaluación, es preciso tener en consideración la finalidad de la prueba y lo que se va a evaluar. Si el objetivo principal de una estación es poner a prueba las habilidades de comunicación con los pacientes, entonces la persona más apropiada para juzgarlo como evaluador será un paciente. Sin embargo, si se va a valorar una tarea práctica compleja, estará más indicado que sea un profesional clínico con conocimientos de la intervención. En la práctica se combinan en la evaluación aquellas realizadas por profesionales clínicos y por pacientes. Los casos simulados en un ordenador, no evalúan ni una cosa ni la otra, quedando más limitados a tareas más próximas a un entrenamiento que a una evaluación.

Por tanto, el resultado dependerá muy poco del evaluador, y mucho del grado alcanzado por el alumno en el aprendizaje de las competencias. Pero para que esto puede servir a efectos comparativos de resultados, la prueba

debe ser única e igual para todos. De hecho, un consejo que se pone de manifiesto en la literatura es muy claro: cuando se diseña una ECOE, el principio fundamental que lo rige es que todos los candidatos completen la misma tarea en el mismo tiempo, y que se califique de acuerdo con un mismo plan. Este es un principio básico para poder comparar resultados. Cuando la prueba no es la misma no se medirá lo mismo².

2. Boursicot K. Performance and workplace assessment. En: Dent J, Harden R, Hunt D, editores. A Practical Guide for Medical Teachers. 6ª ed. Ed. Elsevier; 2021.

Jesús Millán Núñez-Cortés

Director de la Cátedra de Educación Médica,

Universidad Complutense, Madrid, España

Correo electrónico: jesus.millan.nunezcortes@madrid.org

Bibliografía

1. Newble D. Techniques for measuring clinical competence: objective structures clinical examination. Med Educ. 2004;38: 199–203.